直接受到血流冲击的一面易遭受到损害

①**最常累及二尖瓣**，其次是二尖瓣（心房面）和主动脉瓣（心室面）同时受累

VS 感染性心内膜炎:联合性瓣膜损害(二尖瓣和主动脉瓣)最常见

②瓣膜闭锁缘形成**疣状赘生物**，不易脱落，呈灰白色、单行串珠状排列，由**血小板**等构成

变态反应性疾病赘生物:没有细菌而且扒的牢 VS 感染性心内膜炎赘生物有菌且容易脱落

（**白色血栓**）

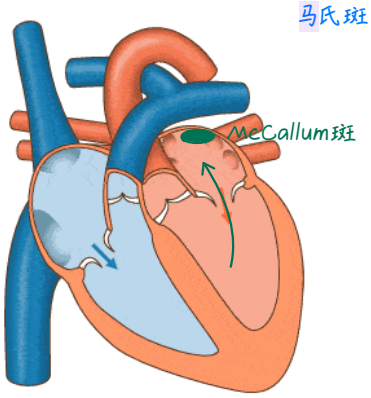
血小板血栓:血流比较快的地方(心腔/动脉),血小板跟不上血流,析出形成血栓

③**病变反复发作可致慢性心瓣膜病**。由于病变所致瓣膜口狭窄或关闭不全，受 ttsx 血流反

临床上二尖瓣狭窄/关闭不全最常见的原因:风湿病

流冲击较重引起**心内膜**灶状增厚（**McCallum 斑**），多见于**左心房**后壁马后炮

马氏斑



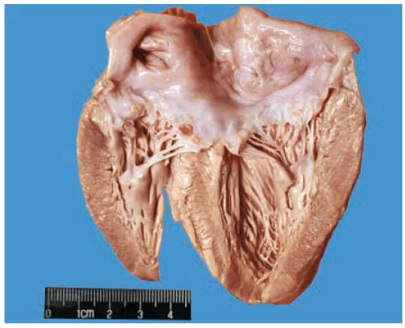


图 9-22 风湿性疣状心内膜炎

二尖瓣闭锁缘可见细小赘生物，有的呈溃疡改变。

2.风湿性心肌炎 胶原纤维存在于血管壁和细胞间质

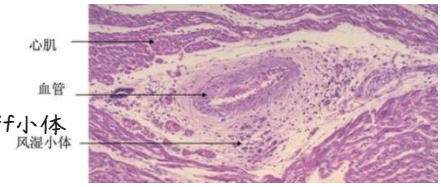
①病变主要累及心肌**间质**结缔组织（间质性心肌炎）

慢波来自肌肉,不是来自肌细胞,而是来自间质细胞

②Aschoff 小体常位于**心肌间质小血管旁**

血液中的单核巨噬细胞穿过血管壁到达细胞间质,继而形成Aschoff小体

③Aschoff 小体机化形成小瘢痕（心肌纤维化）



④累及传导系统可致传导阻滞

3.风湿性心外膜炎/**心包炎**

①浆液渗出为主→心包积液；**纤维素渗出为主→绒毛心** 感性认识:纤维蛋白随心脏搏动拉丝

渗出的纤维素被大量的肉芽组织机化后,变成纤维瘢痕,非常硬

②渗出的大量**纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎** 感性认识:心脏穿了一个非常紧的外套

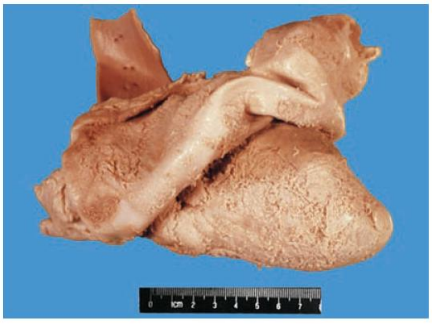


图 9-23 风湿性心外膜炎

心外膜表面有大量纤维蛋白渗出，呈绒毛状。

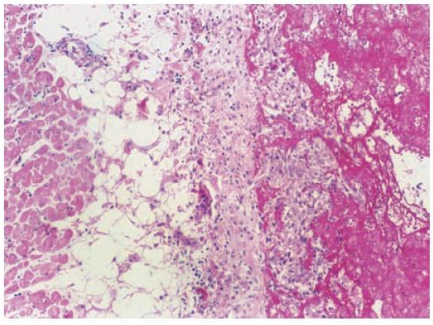


图 9-24 风湿性心外膜炎

渗出的纤维蛋白与心外膜紧密相连。